



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entendiendo al usuario 2



Grupo 01



CASO CLINICO 1



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Key Attribute

Hemipelvectomía traumática con lesión de piso pélvico y derivación digestiva/urinaria

Short Description

Pérdida de un miembro inferior y alteración de la región pélvica, que posterior a fase quirúrgica necesaria adaptación a la silla de ruedas y recuperación progresiva de independencia.

Needs

Antes del accidente, el paciente realizaba actividades personales, sociales y académicas o laborales, en la rehabilitación, las actividades críticas se centran en adaptarse al uso de la silla de ruedas, también debe recuperar progresivamente su independencia en la higiene personal, el vestido, el uso del baño y el manejo de sus dispositivos de derivación.

Challenges

Físicas: Pérdida completa del miembro inferior derecho. Destrucción de la cintura pélvica. Lesión severa del periné. Lesión uretral.
Necesidad de colostomía y cistostomía.
Funcionales: Dificultad para desplazarse. Necesidad de aprender nuevas formas de realizar actividades cotidianas. Dependencia potencial de otras personas durante la recuperación.

Opportunities

Facilitadores: Sobrevivió al trauma inicial. Tratamiento quirúrgico especializado. Cierre de la lesión mediante colgajo miocutáneo. Programa prolongado de rehabilitación. Uso de silla de ruedas como medio de movilidad. Posibilidad de entrenamiento para recuperar independencia.



PUNTOS DE DOLOR

TRAUMA PELVICO SEVERO,
PROCESO PROLONGADO DE
CURACIONES.

DOLOR N°1



HERIDAS Y TEJIDOS
DESVITALIZADOSP.

DOLOR N°2



LESION URETRAL

DOLOR N°3



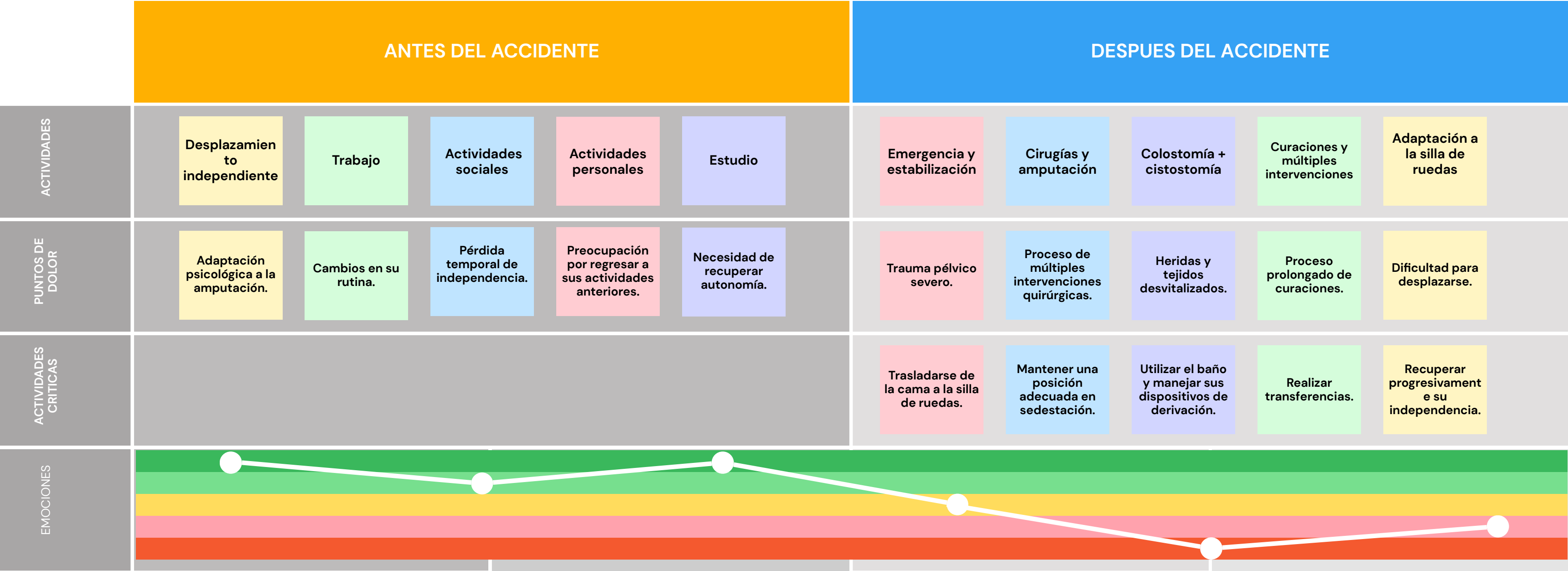
LESIÓN DEL PISO PÉLVICO.

DOLOR N°4





MAPA DE ACTIVIDADES Y DOLOR



[3] R. J. Schoderbek et al., "Traumatic hemipelvectomy: case report and literature review," Arch. Orthop. Trauma Surg., vol. 125, no. 5, pp. 358–362, Jun. 2005.
[4] G. Rodríguez-Morales et al., "Traumatic hemipelvectomy: report of two survivors and review," J. Trauma, vol. 23, no. 7, pp. 615–620, Jul. 1983.



CASO CLINICO 2

Key Attribute

Paraplejía T10 AIS A (completa). Anestesia total por debajo de T10 y en zona perineal/pélvica derecha.

Short Description

Ausencia de hemiarco pélvico derecho (sin isquión). Genera inclinación pélvica y escoliosis neuromuscular reactiva en sedente. Locomoción: 100% independiente en silla de ruedas manual. Marcha protésica descartada por alto gasto energético y falta de control pélvico.

AVD: Conserva fuerza e independencia en miembros superiores. Dependiente en transferencias complejas y manejo de esfínteres (portador de colostomía y prótesis peneana con válvula).

Barreras

Pérdida del punto de apoyo óseo isquiático derecho. Alto riesgo de úlceras por presión (UPP) en el isquión sano (izquierdo) e injertos. Interferencia de la colostomía con cinturones o cinchas de sujeción pélvica. Barreras arquitectónicas en el entorno urbano y transporte.

Facilitadores

Buena potencia muscular en brazos y hombros. Cesta pélvica/asiento adaptado con ventana para la bolsa de colostomía. Atención multidisciplinaria en rehabilitación integral (INR). Red de apoyo familiar motivada en el hogar.



PUNTOS DE DOLOR

COLAPSO POSTURAL:

Fatiga muscular en tronco/espalda por la inclinación continua hacia el lado amputado.

DOLOR N°1

HIPERPRESIÓN ISQUIÁTICA:

Carga de peso concentrada al 100% en el único isquión presente (izquierdo)

DOLOR N°2

DOLOR NEUROPÁTICO/FANTASMA:

Combinación de dolor medular paroxístico con sensación de miembro fantasma pélvico

DOLOR N°3

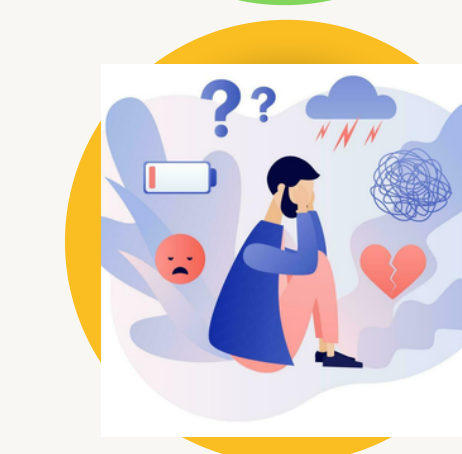
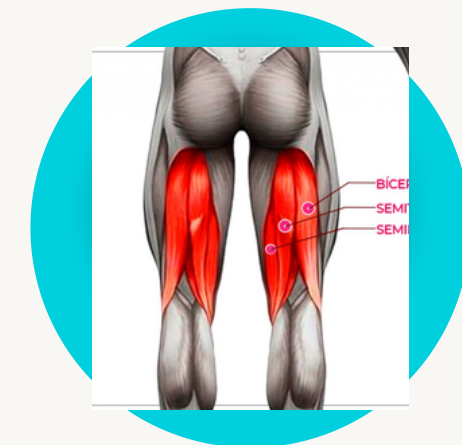
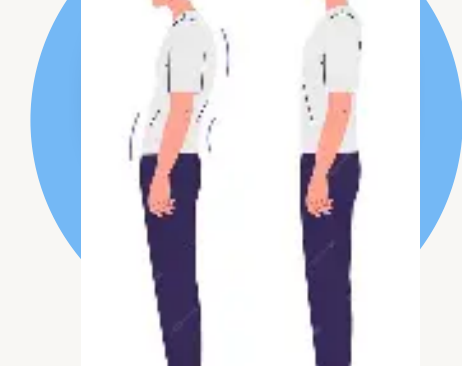
IMPACTO PSICOEMOCIONAL:

Alteración de la imagen corporal y pérdida de autonomía en la higiene íntima/sexual

DOLOR N°4



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA





SEDASTACION

PASA MUCHO
TIEMPO EN LA
SILLA DE
RUEDAS

EXPECTATIVA

SEDESTACIÓN
CONFORTABLE,
MANTENIÉNDOSE
SENTADO DE FORMA
PROLONGADA SIN
PRESENTAR DOLOR
DORSAL NI COLAPSO DE
TRONCO.

TRANSFERENCIA

SU UNICO PUNTO
DE APOYO AL
MOMENTO DE
LEVANTARSE ES
LA DE SU
CINTURA
ESCAPULAR

EXPECTATIVA

AUTONOMÍA EN LAS
TRANSFERENCIAS,
LOGRANDO MOVERSE E
INGRESAR A LA CAMA,
LA SILLA O EL VEHÍCULO
SIN DEPENDER DE LA
FUERZA FÍSICA DE UN
FAMILIAR.

CUIDADO CUTÁNEO/ESTOMAS

RIESGO A
INFECCIONES
POR HERIDAS

EXPECTATIVA

MANTENER LA
INTEGRIDAD CUTÁNEA,
PREVINIENDO
EFICAZMENTE
ÚLCERAS E
INFECCIONES EN LAS
ZONAS DE INJERTO,
COLOSTOMÍA Y PERINÉ.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

BIPEDESTACIÓN

DEPENDENCIA A
UNA PROTESIS
INMOVIL

EXPECTATIVA

BIPEDESTACIÓN
TERAPÉUTICA, ERGUIR
EL CUERPO DE FORMA
ASISTIDA PARA
CONSEGUIR UNA
INTERACCIÓN VISUAL
DE FRENTE Y UNA
MEJORÍA INTESTINAL.



CASO CLÍNICO 3



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Adulto Mayor

Persona

Sexo: Masculino

Edad: 60 años

País: Japón

Contexto Físico:

- Paraplejía Secundaria a lesión medular
- Hemipelvectomía parcial derecha y desarticulación de cadera izquierda

Perfil Funcional

Habilidades Conservadas: Función de los miembros superiores favorece el autocuidado, las transferencias y manejo del socket

Principales Limitaciones: Paraplejía y pérdida extensa de estructuras pélvicas impide una sedestación estable

Observación: Riesgo de úlceras por presión, manejo de la estoma y cistotomía

Barreras

Físicas:

- Paraplejía
- Pérdida de estructuras pélvicas
- Dificultad para mantener el equilibrio sentado
- Riesgo de lesiones cutáneas

Ambientales:

- Escaleras
- Baños no adaptados
- Transporte Inaccesible

Facilitadores

Destacados:

- Conservación de la función de los miembros superiores
- Rehabilitación Especializada
- Socket transpelviano personalizado

Expectativas

- Prevenir lesiones cutáneas
- Recuperar la movilidad
- Restablecer la participación comunitaria
- Recuperar una sedestación estable y confortable
- Realizar actividades de la vida diaria con mayor independencia
- Colocarse y retirarse el socket sin asistencia

[6] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpeltic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: [10.7888/juoe.34.175](https://doi.org/10.7888/juoe.34.175).

[7] «Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Health-Care Professionals», The Journal of Spinal Cord Medicine, vol. 28, n.o 5, pp. 434-470, ene. 2005, doi: [10.1080/10790268.2005.11753844](https://doi.org/10.1080/10790268.2005.11753844).

[8] N. R. Rosin, R. S. Tabibi, J. D. Trimbath, y M. K. Henzel, «A Primary Care Provider's Guide to Prevention and Management of Pressure Injury and Skin Breakdown in People With Spinal Cord Injury», Top Spinal Cord Inj Rehabil, vol. 26, n.o 3, pp. 177-185, 2020, doi: [10.46292/sci2603-177](https://doi.org/10.46292/sci2603-177).



Mapa de Actividades Críticas

	Vida Diaria	Laborales/Educativas	Rehabilitación	Prevención y Mantenimiento
Actividades	- Vestido - Higiene - Transferencia	- Conducción - Desplazamientos - Participación Social	- Sedestación - Transferencias - Colocación/retirada del socket	- Inspección de la piel - Los alivios de presión - El control del ajuste del socket
Nivel de Independencia	DEPENDIENTE	REQUIERE AYUDA PARCIAL	REQUIERE AYUDA PARCIAL	INDEPENDIENTE
Dificultades	Requiere sedestación estable y estrategias adaptadas a la paraplejia	Requiere adaptaciones del transporte y entorno	Requiere asistencia	Riesgo de lesiones cutáneas y la necesidad de vigilancia continua
Impacto en la Calidad de Vida	La autonomía del usuario	La integración del usuario	Independencia funcional y una movilidad segura	Prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida

[6] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelveic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: [10.7888/juoeh.34.175](https://doi.org/10.7888/juoeh.34.175).

[7] «Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Health-Care Professionals», The Journal of Spinal Cord Medicine, vol. 28, n.o 5, pp. 434-470, ene. 2005, doi: [10.1080/10790268.2005.11753844](https://doi.org/10.1080/10790268.2005.11753844).

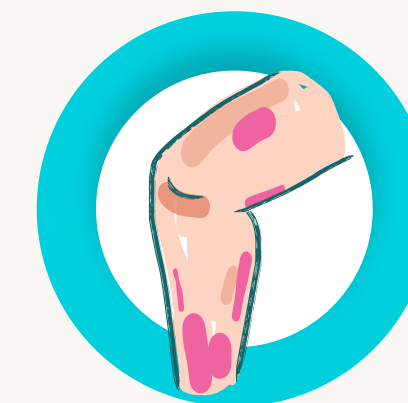
[8] N. R. Rosin, R. S. Tabibi, J. D. Trimbath, y M. K. Henzel, «A Primary Care Provider's Guide to Prevention and Management of Pressure Injury and Skin Breakdown in People With Spinal Cord Injury», Top Spinal Cord Inj Rehabil, vol. 26, n.o 3, pp. 177-185, 2020, doi: [10.46292/sci2603-177](https://doi.org/10.46292/sci2603-177).



PRINCIPALES PUNTOS DE DOLOR

INCAPACIDAD INICIAL PARA
SENTARSE

PUNTO 1



NECESIDAD DE CONTROLAR
CONTINUAMENTE LAS
PRESIONES SOBRE LOS TEJIDOS

PUNTO 2



DIFICULTAD POTENCIAL DE LAS
TRANSFERENCIAS

PUNTO 3

DEPENDENCIA INICIAL PARA
UTILIZAR EL DISPOSITIVO

PUNTO 4

